



Doença Inflamatória Intestinal

Manifestações Sistêmicas, Alterações Laboratoriais e Evolução Clínica

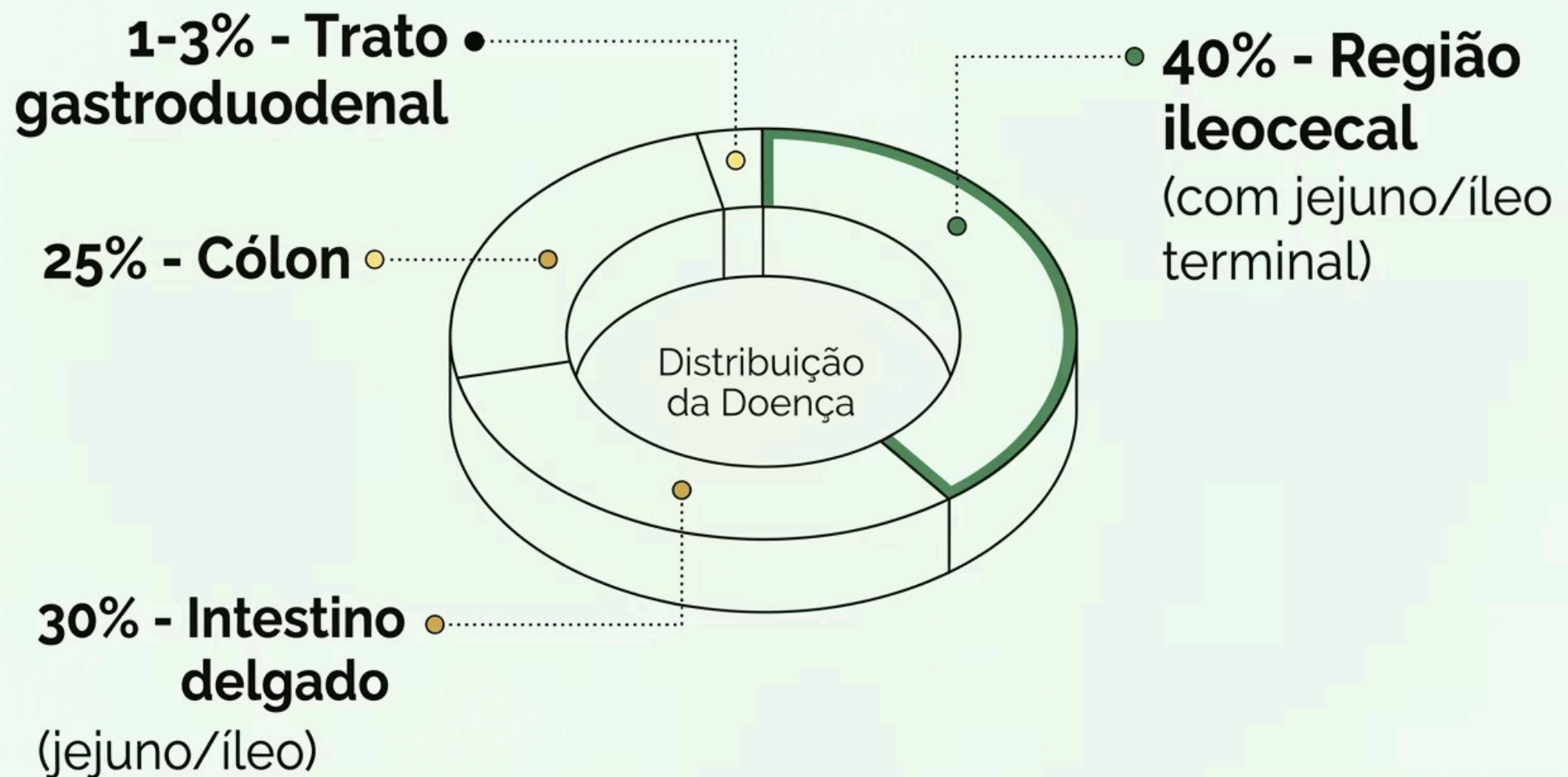
Módulo avançado de Gastroenterologia — Apostila 4 (Páginas 61–80). Este material aborda a visão integrada da DII, com foco em localização da doença, diferenciação clínica, marcadores laboratoriais, evolução e manifestações extraintestinais.

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA

GASTROENTEROLOGIA

Localização da Doença de Crohn

A Doença de Crohn é caracterizada por sua capacidade de acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Essa distribuição variável explica a grande diversidade de apresentações clínicas observadas na prática.



A região ileocecal é acometida em **40% dos casos**, sendo a localização mais frequente e responsável pelo quadro clássico de dor em fossa ilíaca direita. O envolvimento isolado do intestino delgado e do cólon também é comum, enquanto o comprometimento gastroduodenal é raro, porém de impacto significativo.

Crohn vs. Retocolite: Visão Integrada

A diferenciação entre as duas principais formas de DII vai muito além da anatomia. O comportamento clínico, o padrão de complicações e a resposta ao tratamento são elementos essenciais para o diagnóstico diferencial.

Doença de Crohn

- Acomete todo o trato gastrointestinal
- Lesões segmentares ("skip lesions")
- Alta frequência de fístulas e estenoses
- Menor presença de sangue nas fezes
- Comprometimento transmural

Retocolite Ulcerativa

- Restrita ao cólon (sempre com acometimento retal)
- Inflamação contínua e confluyente
- Sangramento retal frequente
- Maior risco de megacólon tóxico
- Comprometimento mucoso superficial

Alterações Laboratoriais na DII

Os exames laboratoriais são ferramentas indispensáveis para avaliar a atividade inflamatória, identificar complicações e monitorar a resposta ao tratamento. Nenhuma alteração isolada é diagnóstica, mas o conjunto dos achados orienta a conduta clínica.

Proteínas de Fase Aguda

Elevação de PCR e VHS refletem atividade inflamatória sistêmica. A PCR ultrasensível é especialmente útil no monitoramento.

Anemia

Extremamente comum, de origem multifatorial — ferropriva, da doença crônica ou macrocítica por deficiência de B12/folato.

Hipoalbuminemia

Marcador de inflamação e desnutrição. Albumina baixa indica doença grave e está associada a pior prognóstico.

Alterações Nutricionais

Deficiências de micronutrientes (zinco, magnésio, vitaminas lipossolúveis) são frequentes, especialmente no Crohn com acometimento de intestino delgado.



Marcadores Sorológicos na DII

Determinados anticorpos séricos auxiliam na diferenciação entre Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa, mas sua aplicação deve ser interpretada dentro do contexto clínico completo.

pANCA

Anticorpo anticitoplasma de neutrófilo perinuclear

Mais associado à **Retocolite Ulcerativa**. Presente em 60–70% dos casos. Útil quando positivo em pacientes com colite indeterminada.

ASCA

Anticorpos anti-Saccharomyces cerevisiae

Mais associado à **Doença de Crohn**. Presente em 50–70% dos casos. Correlaciona-se com doença ileal e comportamento penetrante.

📄 ⚠️ **Atenção:** Os marcadores sorológicos não são definitivos e não substituem a avaliação endoscópica e histológica. Servem como apoio diagnóstico complementar, especialmente em casos de difícil classificação.

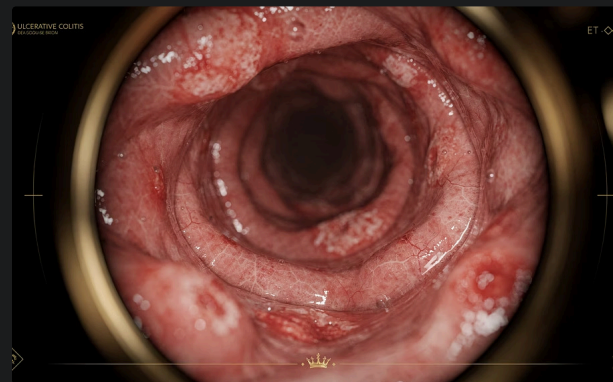
Diferenças Endoscópicas e Radiológicas

O padrão endoscópico e as alterações radiológicas são pilares fundamentais no diagnóstico diferencial das duas formas de DII. Cada doença apresenta características morfológicas bastante distintas.



Doença de Crohn

- Envolvimento frequente do intestino delgado
- Úlceras profundas ("em pedra de calçamento")
- Lesões segmentares com áreas sãs intercaladas
- Comprometimento da gordura mesentérica (creeping fat)



Retocolite Ulcerativa

- Envolvimento contínuo e confluyente
- Inflamação mucosa superficial
- Comprometimento retal sempre presente
- Pseudopólipos inflamatórios nas formas graves

Evolução da Retocolite Ulcerativa

A evolução clínica da Retocolite Ulcerativa é diretamente influenciada pela extensão do acometimento colônico. Quanto maior a extensão da doença, maior a probabilidade de complicações graves ao longo do tempo.

Progressão da Inflamação

Expansão proximal da doença pode ocorrer ao longo dos anos, especialmente em pacientes com controle inadequado.

Sangramento

Hematoquezia recorrente é a manifestação mais característica, podendo levar à anemia ferropriva grave.

Necessidade de Cirurgia

Colectomia pode ser necessária em 20–30% dos pacientes ao longo da vida, especialmente nas formas extensas.

Complicações Graves

Megacólon tóxico, perfuração e displasia/câncer colorretal são complicações temidas nas formas extensas e de longa duração.



História Natural da Retocolite

A Retocolite Ulcerativa apresenta curso crônico, com alternância de períodos de remissão e recaída. Uma minoria dos pacientes evolui para formas fulminantes, que representam emergências médicas.

Forma Crônica Recidivante

A apresentação mais comum. Pacientes alternam fases de atividade com períodos de remissão clínica. A manutenção da remissão é o principal objetivo terapêutico.

Forma Fulminante (Grave)

Caracterizada por critérios de gravidade bem definidos:

- Mais de 10 evacuações sanguinolentas por dia
- Febre acima de 38,5°C
- Taquicardia e sinais de toxemia
- Anemia e elevação importante de marcadores inflamatórios

Critérios de Truelove e Witts

Classifica a gravidade da RCU como leve, moderada ou grave. Pacientes graves necessitam de internação e corticoterapia intravenosa imediata.

História Natural da Doença de Crohn

Ao contrário da Retocolite, a Doença de Crohn apresenta comportamento progressivo e evolutivo, com tendência ao desenvolvimento de complicações estruturais ao longo dos anos, mesmo em pacientes inicialmente responsivos ao tratamento clínico.



A maioria dos pacientes inicia com fenótipo inflamatório, mas com o tempo evolui para padrões estenosantes ou penetrantes — ambos associados à maior morbidade e necessidade de intervenção cirúrgica. O diagnóstico precoce e o tratamento agressivo visam retardar essa progressão fenotípica.

Necessidade de Cirurgia na Doença de Crohn

A probabilidade de intervenção cirúrgica aumenta progressivamente com o tempo de doença. Estudos mostram que cerca de **70–80% dos pacientes** com Doença de Crohn necessitarão de pelo menos uma cirurgia ao longo da vida.

70%

Cirurgia ao longo da vida

Proporção de pacientes que necessitam de intervenção cirúrgica em algum momento.

35%

Recidiva pós-cirúrgica

Taxa de recorrência endoscópica significativa no primeiro ano após ressecção ileocecal.

30%

Segunda cirurgia

Pacientes que necessitam de reintervenção em 10 anos após a primeira cirurgia.

❏ **⚠ Conceito essencial:** A cirurgia não é curativa na Doença de Crohn. A doença recorre no segmento proximal à anastomose. O tratamento medicamentoso de manutenção pós-operatório é fundamental para reduzir a recidiva.



Manifestações Extraintestinais da DII

Até 50% dos pacientes

A Doença Inflamatória Intestinal não se limita ao trato gastrointestinal. Até metade dos pacientes apresenta manifestações sistêmicas em algum momento do curso da doença — e essas manifestações podem surgir **antes, durante ou após** os sintomas intestinais, frequentemente sendo a primeira pista diagnóstica.

Articulares

Manifestação mais frequente (até 40%)

 Dermatológicas

Eritema nodoso e pioderma gangrenoso

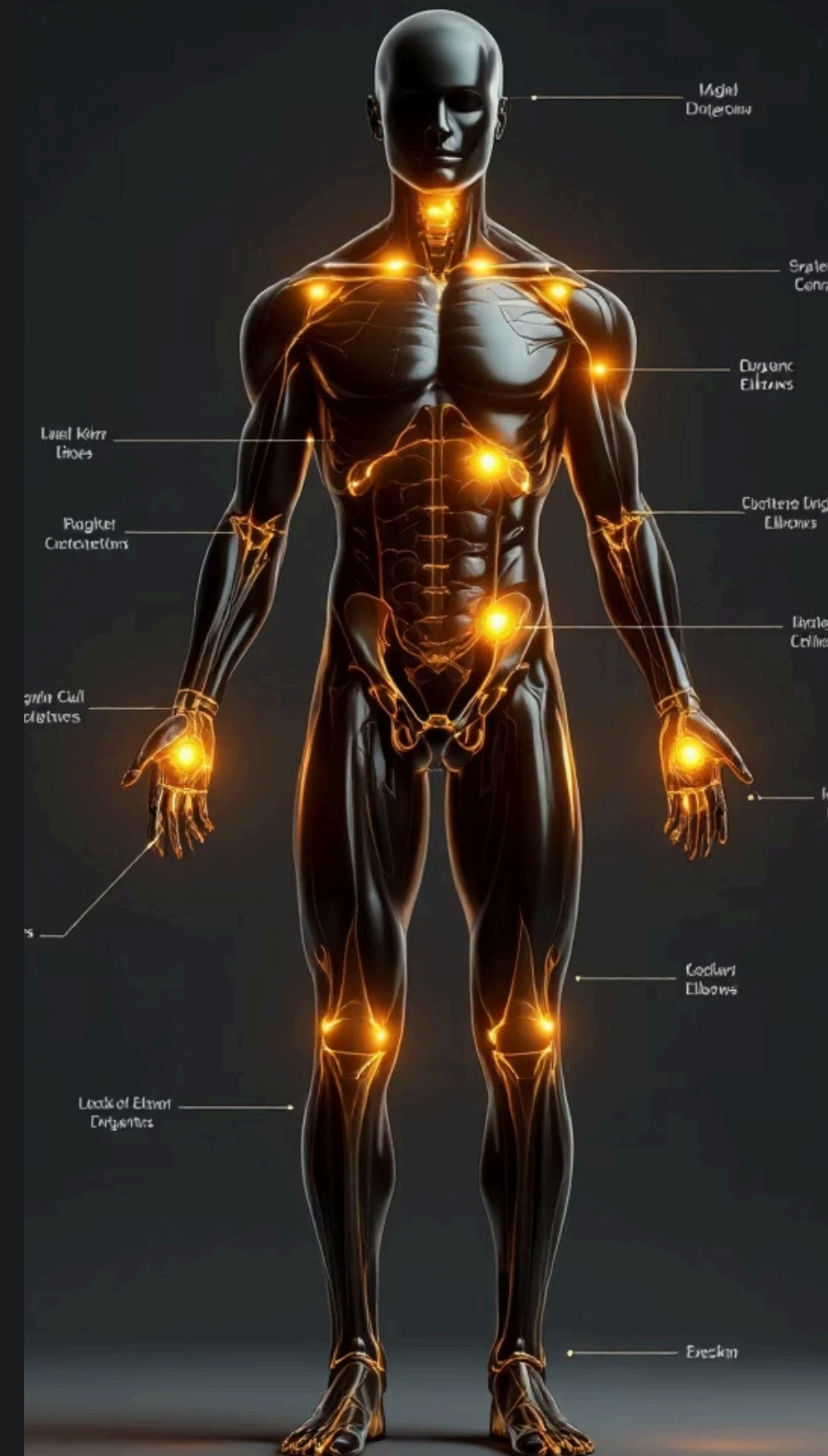
Oculares

Episclerite e uveíte anterior



Hepáticas

Colangite esclerosante primária (CEP)



Classificação das Manifestações Extraintestinais

As manifestações extraintestinais podem ser divididas conforme sua relação com a atividade da doença intestinal — distinção essencial para orientar o tratamento.

Associadas à Atividade da Doença

Tendem a melhorar com o controle da inflamação intestinal:

- **Artrite periférica** — articulações grandes
- **Eritema nodoso** — nódulos subcutâneos dolorosos
- **Episclerite** — hiperemia ocular
- **Síndrome de Sweet** — dermatose neutrofílica

Independentes da Atividade da Doença

Requerem tratamento específico e independente:

- **Espondilite anquilosante** — artropatia axial
- **Pioderma gangrenoso** — úlceras necróticas cutâneas
- **Uveíte anterior** — risco de perda visual
- **Colangite esclerosante primária** — doença hepática crônica

Anemia na DII: Tipos e Impacto

A anemia é a complicação sistêmica mais frequente na DII, presente em até **74% dos pacientes hospitalizados**. Seu reconhecimento e tratamento são fundamentais para a qualidade de vida e a resposta terapêutica.

1

Anemia Ferropriva

Causada por perda sanguínea intestinal crônica. É a forma mais comum. Caracteriza-se por microcitose e hipocromia. Requer reposição de ferro, preferencialmente endovenosa nos casos moderados a graves.

2

Anemia da Doença Crônica

Mediada por citocinas pró-inflamatórias (IL-6, hepcidina). Ferro sérico baixo, mas ferritina normal ou elevada. O tratamento requer controle da inflamação subjacente.

3

Anemia Macrofítica

Decorrente de deficiência de vitamina B12 (má absorção ileal no Crohn) ou folato. Importante lembrar que o uso de sulfassalazina e metotrexato também pode causar deficiência de folato.

Causas da Anemia na DII



A identificação da causa predominante é essencial para a escolha terapêutica correta. Em muitos pacientes, múltiplos mecanismos coexistem, tornando o diagnóstico e o tratamento da anemia particularmente desafiadores na prática clínica.

Impacto Sistêmico da DII

A DII deve ser reconhecida como uma doença verdadeiramente sistêmica, com repercussões que ultrapassam os limites do intestino. Seu impacto abrange múltiplos sistemas orgânicos de forma simultânea.



Nutricional

Desnutrição, perda de peso, déficit de micronutrientes e vitaminas lipossolúveis.



Hematológico

Anemia multifatorial, leucocitose, trombocitose reativa nos surtos inflamatórios.



Imunológico

Desregulação imune, susceptibilidade a infecções oportunistas, especialmente com uso de imunossupressores.



Articular

Artrite periférica e espondiloartrite, que podem ser altamente incapacitantes.



Dermatológico

Eritema nodoso e pioderma gangrenoso, de frequência e gravidade variáveis.

Manifestações Dermatológicas e Articulares



Manifestações Dermatológicas

Eritema Nodoso: Nódulos subcutâneos dolorosos, eritematosos, localizados principalmente nos membros inferiores. Associado à atividade da doença. Mais comum no Crohn.

Pioderma Gangrenoso: Úlceras cutâneas necróticas de bordas violáceas, muito dolorosas. Independente da atividade intestinal. Tratamento com corticoides e imunossupressores.



Manifestações Articulares

Artrite Periférica: Acomete grandes articulações (joelhos, tornozelos, cotovelos). Não erosiva, paralela à atividade intestinal.

Espondiloartrites: Sacroileíte e espondilite anquilosante. Independentes da atividade intestinal. Associação com HLA-B27. Podem ser altamente incapacitantes e de evolução autônoma.

Manifestações Oculares e Colangite Esclerosante

Episclerite

Inflamação da episclera, com hiperemia ocular sem dor intensa. Frequentemente associada à atividade da doença intestinal. Tende a responder bem ao controle da DII.

Uveíte Anterior

Inflamação da úvea, com dor ocular intensa, fotofobia e visão turva.

Independente da atividade intestinal.

Requer tratamento oftalmológico urgente, pois pode causar perda visual permanente.

Colangite Esclerosante Primária (CEP)

Associada principalmente à Retocolite Ulcerativa (em até 5% dos casos). Doença hepática progressiva com fibrose biliar. Aumenta significativamente o risco de colangiocarcinoma e câncer colorretal. Pode indicar transplante hepático.

Complicações Sistêmicas Graves

A DII mal controlada pode evoluir com complicações sistêmicas que impactam diretamente a morbimortalidade dos pacientes. O reconhecimento precoce é fundamental para a prevenção.

→ Desnutrição Grave

Consequência da má absorção, hiporexia e estado inflamatório crônico. Aumenta o risco cirúrgico e prejudica a cicatrização. Requer suporte nutricional especializado.

→ Infecções Oportunistas

Decorrentes do uso de imunossupressores e biológicos. Tuberculose, pneumocistose e infecções fúngicas devem ser rastreadas. Triagem obrigatória antes do início da terapia imunossupressora.

→ Tromboembolismo Venoso

Risco 3x maior em pacientes com DII ativa. Estado pró-trombótico mediado por inflamação sistêmica. Profilaxia durante internações é essencial.

→ Complicações Hepáticas

CEP, esteatose hepática, hepatotoxicidade medicamentosa. O fígado deve ser monitorado durante o tratamento.

Integração Clínica: O Paciente com DII

O manejo adequado da DII exige uma visão ampla e integrada do paciente. O gastroenterologista deve atuar como coordenador de um cuidado verdadeiramente multidisciplinar, articulando diferentes especialidades e dimensões clínicas.

Sintomas Intestinais

Avaliação da atividade da doença, padrão de evacuações, dor e sangramento.

Evolução da Doença

Monitoramento do fenótipo, risco de progressão e necessidade de escalonamento terapêutico.



Manifestações Sistêmicas

Rastreamento ativo de articulações, pele, olhos e fígado.

Exames Laboratoriais

PCR, hemograma, albumina, calprotectina fecal e perfil nutricional.

Visão Final da DII: Conceitos-Chave

A Doença Inflamatória Intestinal deve ser compreendida em toda sua complexidade — não apenas como uma doença do intestino, mas como uma condição crônica, progressiva, sistêmica e multifatorial que exige estratégia terapêutica abrangente.



Crônica

Sem cura definitiva, exige acompanhamento contínuo ao longo de toda a vida.



Progressiva

Tende a evoluir para fenótipos mais complexos sem tratamento adequado e precoce.



Sistêmica

Afeta múltiplos órgãos e sistemas além do trato gastrointestinal.



Multifatorial

Interação entre genética, microbioma, imunidade e fatores ambientais.

 **Ponto-chave final:** O sucesso do tratamento depende do diagnóstico precoce, da estratégia terapêutica individualizada e do acompanhamento contínuo e multidisciplinar — pilares inegociáveis no cuidado ao paciente com DII.